carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA

Semana 09: Ficha de evaluación

Lic. Jhonatan De la Cruz Pérez
Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación
Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud

Presente.

Logro de la sesión

Reconocer los conceptos, características y tipos de fichas de evaluación en el Servicio de Terapia Física.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Semana 09: Ficha de evaluación

1. Definición
2. Estructura
3. Orden
4. Clasificación
5. Interpretación

Presente.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES DEBERÍA TENER UNA FICHA DE EVALUACIÓN EN TERAPIA FÍSICA?

La evaluación es entendida como un **proceso dinámico de análisis de información** con el cual el fisioterapeuta realiza juicios clínicos basados en los datos obtenidos durante la examinación.

Esta evaluación **va plasmada en una ficha de evaluación** con la finalidad de seguir un orden bajo ciertos protocolos que permiten dar una interpretación veraz y lo más exacta posible del resultado para que el licenciado pueda desarrollar un programa personalizado para el paciente.

Evaluación subjetiva

- Valora las características del dolor y síntomas desde la percepción del paciente.

Evaluación analítica

- Examina diferentes tejidos del cuerpo (musculatura, tendones, ligamentos, etc.) mediante la observación, inspección, palpación y exploración.

Evaluación funcional

- Valora de acuerdo a la capacidad que tiene el paciente para ejecutar las actividades de la vida diaria.

DEFINICIÓN

La Ficha de Evaluación es un elemento básico para el abordaje fisioterapéutico previo al planteamiento de cualquier tratamiento.

Valora las capacidades, alteraciones, deficiencias, oportunidades y complicaciones del paciente, permitiendo desarrollar protocolos de tratamiento y formular recomendaciones para su mejora siempre centrándose en la funcionalidad física del usuario.

Nos permite tener un punto de partida acerca de la situación física del paciente para el seguimiento de su evolución, y así el licenciado que evalúa al paciente pueda reformular el tratamiento o mejorarlo.

¿QUÉ INGRESA EN UNA FICHA DE EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA?

- Datos personales
- Anamnesis
- Observación
- Inspección
- Palpación
- Exploración
- Valoración neurológica
- Diagnóstico funcional (fisioterapéutico)
- Plan de tratamiento
- Firma y sello

Datos personales

Datos básicos para identificar al paciente.	Edad, sexo, estado civil, ocupación, etc.

Anamnesis

Entrevista corta y enfocada a obtener datos relevantes para entender la situación de salud.	Antecedentes familiares, comorbilidades, evolución de la enfermedad, características del dolor, etc.

Observación

Análisis visual del paciente de forma global	Actitud postural, empleo de ayudas biomecánicas, apoyo social, balance emocional

Inspección

Análisis visual del paciente de forma específica (zona de dolor)	Características de la piel, alineación articular, heridas, etc.

Palpación

Palpación de estructuras presuntamente lesionadas	Musculatura, tendones, ligamentos, bursas, etc.

Exploración

Medición de las principales capacidades físicas	Valoración del rango articular y de la fuerza muscular de la zona lesionada o segmento completo

Valoración neurológica

Medición de la sensibilidad del paciente tanto superficial como profunda.	Este punto depende de la necesidad o del tipo de paciente.

Diagnóstico funcional

Diagnóstico fisioterapéutico determinado por el licenciado	Se centra principalmente en las disfunciones y limitaciones que presenta el paciente y no tanto en la patología de fondo.

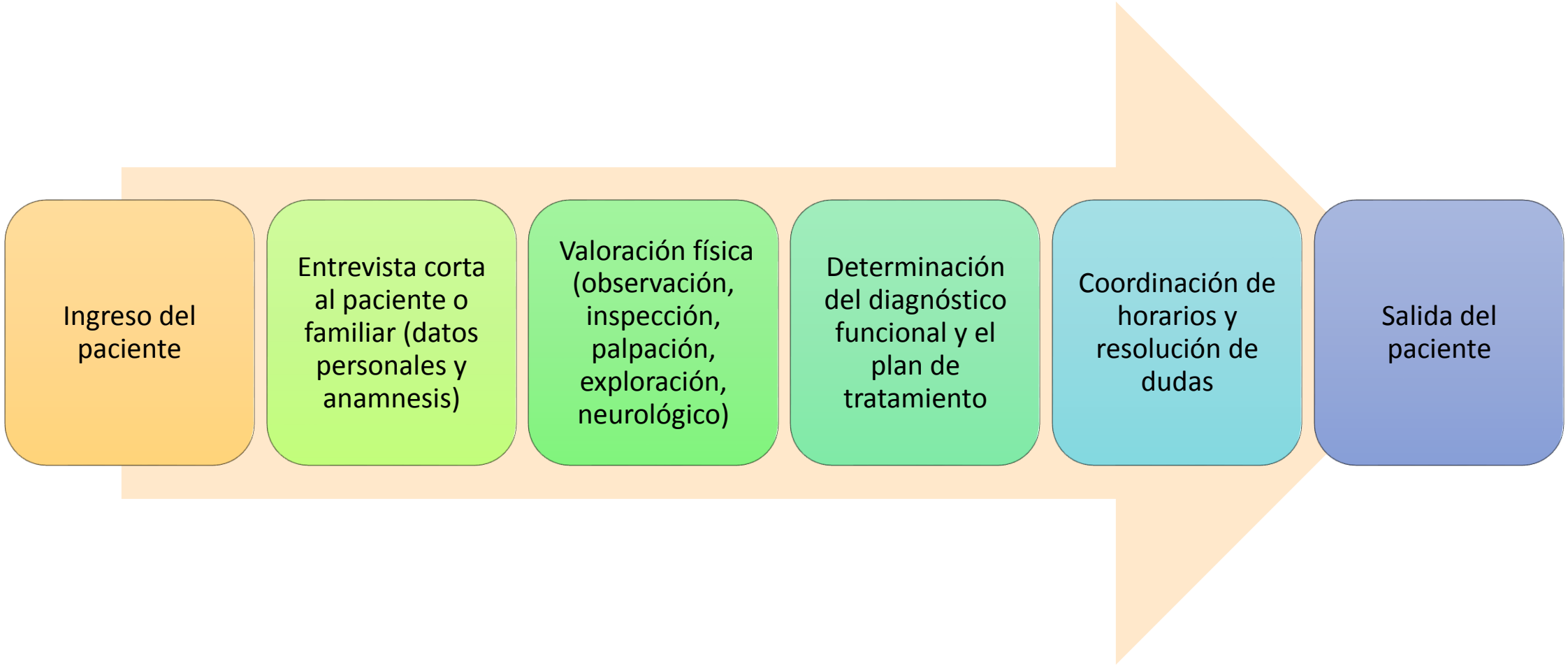
Plan de tratamiento

Se consideran los objetivos del tratamiento (disminuir el dolor, aumentar fuerza muscular, etc.)	Se presentan las estrategias a utilizar en el caso (termoterapia, ultrasonido, masoterapia, etc.)

Firma y sello

Al ser un documento legal, debe presentar la firma y sello del evaluador (se incluye el número de colegiatura).	La ficha de evaluación fisioterapéutica la firma el licenciado.

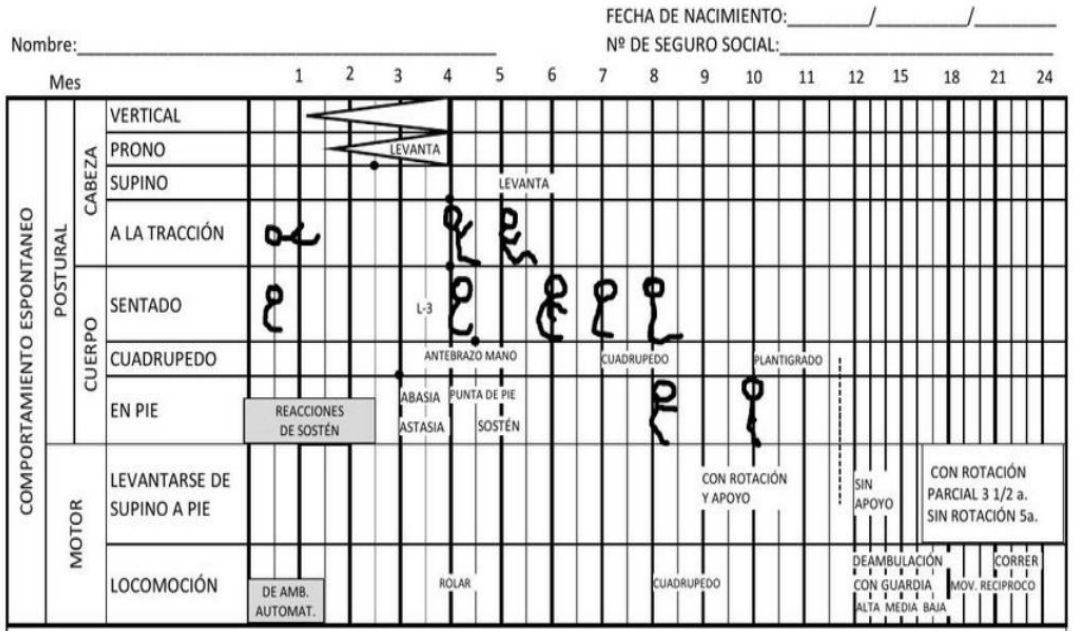
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

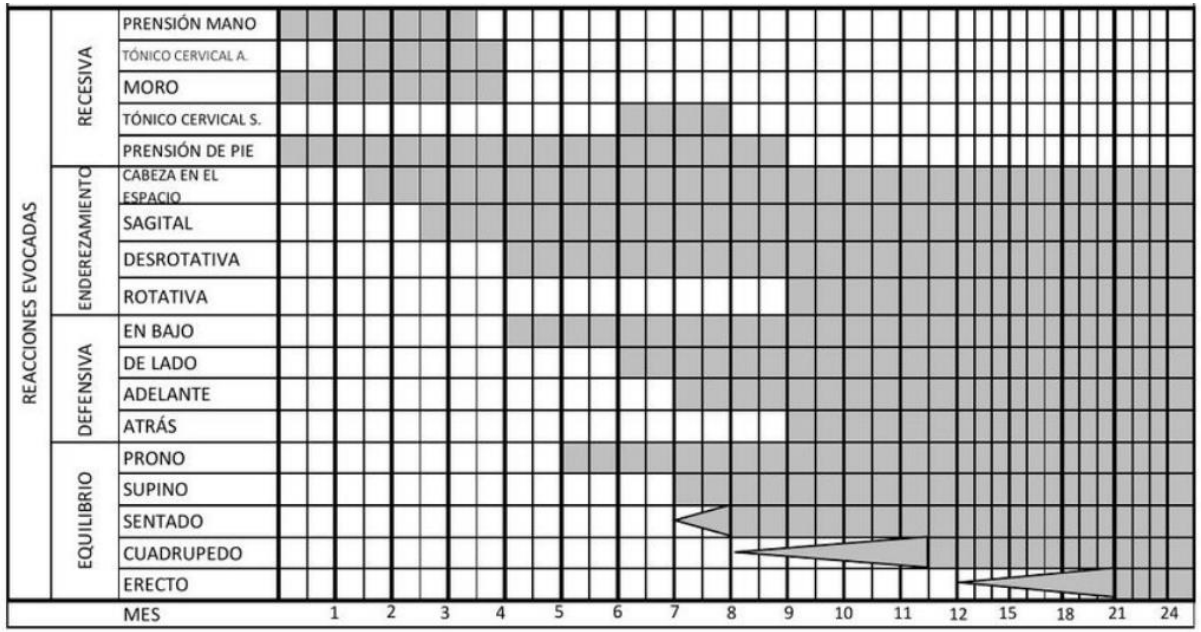


LUGAR DE EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA

- Buena iluminación y ventilación
- Mobiliario básico
- Implementos básicos
- Espacios diferenciados para entrevista y valoración física
- Medidas de bioseguridad
- Infraestructura óptima y amplia

FICHAS PEDIÁTRICAS



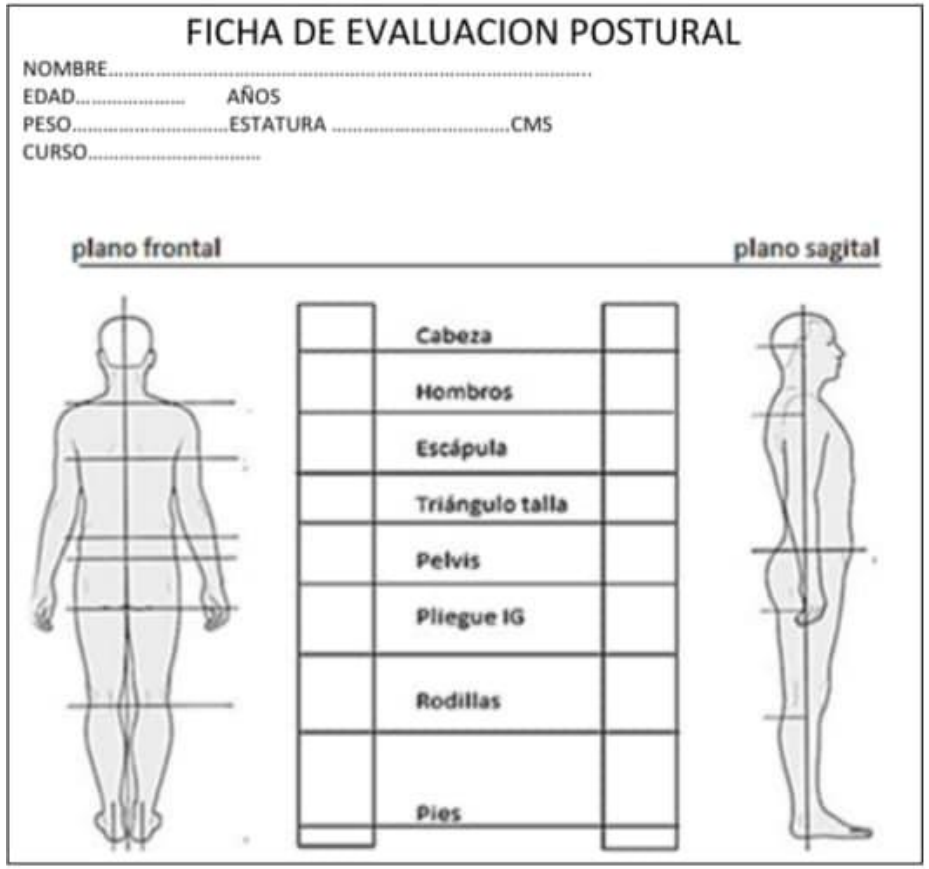


TEST DE MILANI COMPARETTI (DESARROLLO PSICOMOTOR)

Principalmente enfocadas a evaluar la motricidad fina y gruesa, el neuro desarrollo o postura.

FICHA POSTURAL

Valora cuadros como escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, valgo, varo, etc.


FICHA DE EVALUACION POSTURAL

NOMBRE.....
EDAD..... AÑOS
PESO.....ESTATURA .....CMS
CURSO.....

plano frontal | plano sagital

Cabeza	
Hombros	
Escápula	
Triángulo talla	
Pelvis	
Pliegue IG	
Rodillas	
Pies	

FICHA MUSCULOESQUELÉTICA

VALORACIÓN DE TERAPIA FÍSICA

FECHA: _____

NOMBRE: _____ MATRÍCULA: _____
SEXO: _____ EDAD: _____ SALA: _____ TELÉFONO: _____ RELIGIÓN: _____
OCUPACIÓN: _____ ESTADO CIVIL: _____ MÉDICO TRATANTE: _____

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS.

ORIGINARIO DE:	RADICA EN:	ESTADO CIVIL:	OCUPACIÓN:
ESCOLARIDAD:	RELIGIÓN:	SVS. MUNICIPALES:	HABITACIÓN:
TABAQUISMO: TIEMPO DE EVOLUCIÓN POSITIVO ( ) NEGATIVO ( )	ETILISMO: TIEMPO DE EVOLUCIÓN POSITIVO ( ) NEGATIVO ( )	HIGIENE PNAL.:	ALIMENTACIÓN:
DOMINIO: DIESTRO ( ) ZURDO ( )	HIJOS:	PASATIEMPO/ ACTIV. FÍSICA	OTROS:

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS Y HEREDOFAMILIARES:

DIABETES:	HTA:	CÁNCER:	ENF. REUMAT.		CARDIOPATÍAS:	CIRUGÍAS:
ALERGIAS:	TRANSFUSIONES:	ACCIDENTES:	ENCAMES:	FRACTURAS:	SIGNOS VITALES: TA_____TEMP_____FC_____FR_____	

DIAGNÓSTICO MÉDICO EN REHABILITACIÓN

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA I			
REFLEJOS	SENSIBILIDAD	LENGUAJE Y ORIENTACIÓN	OTROS

ESPASMO O CONTRACTURA MUSCULAR
SITIO

CICATRIZ QUIRÚRGICA					
SITIO	QUELOIDE	RETRACTIL	ABIERTA	CON ADHERENCIAS	HIPERTRÓFICA

MARCHA					
LIBRE	CLAUDICANTE	CON AYUDAS	ESPÁSTICA	ATÁXICA	OTRAS

TRASLADOS				
VAL. INICIAL	INDEPENDIENTE	EN SILLA DE RUEDAS	CON AYUDAS	CAMILLA
VAL. FINAL	INDEPENDIENTE	EN SILLA DE RUEDAS	CON AYUDAS	CAMILLA

DOLOR
DOLOR: REGIÓN PRINCIPAL Y LA IRRADIACIÓN DEL DOLOR: _____

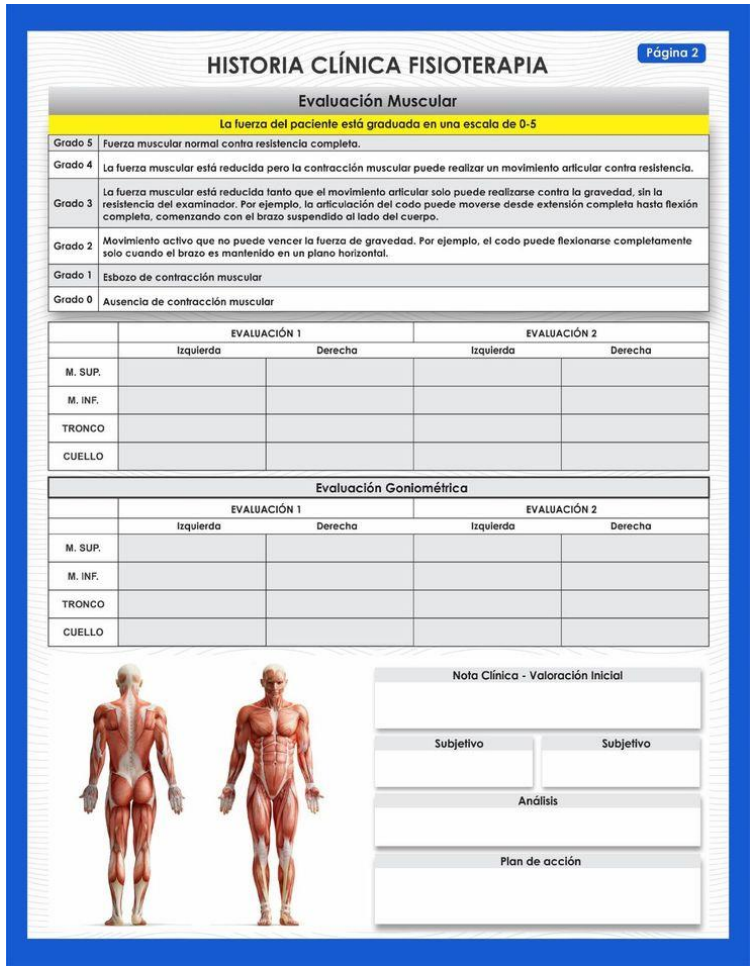
Escala visual Analógica: EVA; sin dolor es 0, pero dolor posible es 10

No valorado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Escala dolor Wong-Baker (pediátrica)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inicial: _____ Final: _____



Página 2

HISTORIA CLÍNICA FISIOTERAPIA

Evaluación Muscular	
La fuerza del paciente está graduada en una escala de 0-5	
Grado 5	Fuerza muscular normal contra resistencia completa.
Grado 4	La fuerza muscular está reducida pero la contracción muscular puede realizar un movimiento articular contra resistencia.
Grado 3	La fuerza muscular está reducida tanto que el movimiento articular solo puede realizarse contra la gravedad, sin la resistencia del examinador. Por ejemplo, la articulación del codo puede moverse desde extensión completa hasta flexión completa, comenzando con el brazo suspendido al lado del cuerpo.
Grado 2	Movimiento activo que no puede vencer la fuerza de gravedad. Por ejemplo, el codo puede flexionarse completamente solo cuando el brazo es mantenido en un plano horizontal.
Grado 1	Esbozo de contracción muscular
Grado 0	Ausencia de contracción muscular

	EVALUACIÓN 1		EVALUACIÓN 2	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
M. SUP.				
M. INF.				
TRONCO				
CUELLO				

Evaluación Goniométrica				
	EVALUACIÓN 1		EVALUACIÓN 2	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
M. SUP.				
M. INF.				
TRONCO				
CUELLO				

Nota Clínica - Valoración Inicial

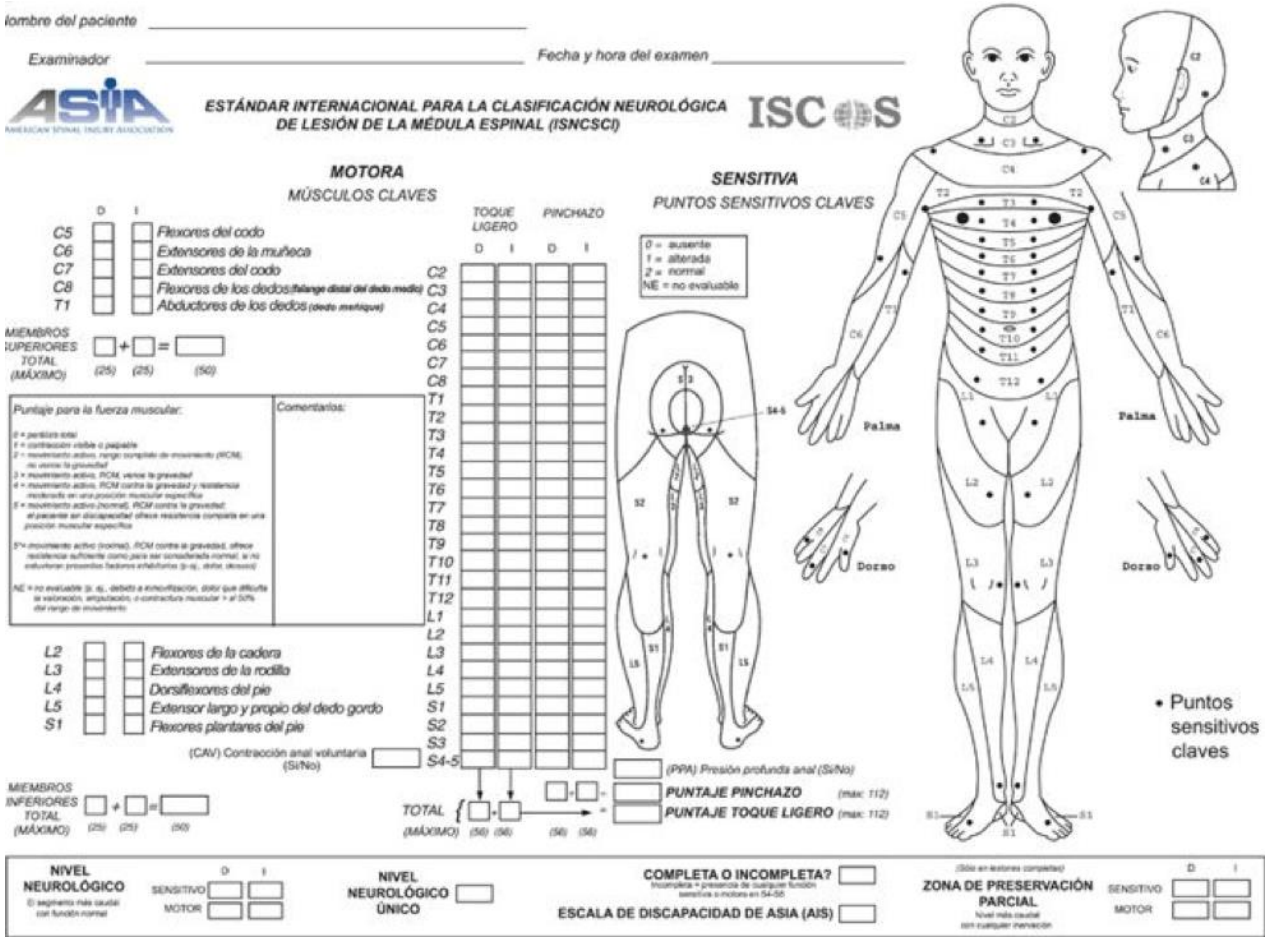
Subjetivo | Subjetivo

Análisis

Plan de acción

Representa la ficha estándar (traumatológica, deportiva, reumatológica, algias, etc.) y valora cuadros como tendinitis, esguinces, cervicalgia, distensiones musculares o pueden ser usadas después de una intervención quirúrgica.

FICHA NEUROLÓGICA



Tono Muscular

Escala de Ashworth modificada		
0	Tono muscular normal	
1	Leve incremento del tono, que se nota al final del mov.	
1+	Leve incremento del tono, que se nota en menos de la mitad del recorrido	
2	Moderado aumento del tono, que se nota en casi todo el recorrido articular	
3	Considerable aumento del tono, movilización pasiva difícil	
4	Casi imposible o imposible movilizaciones pasivas	

Temblor en reposo	
Temblor en movimiento	
Distonia	
Otros mov. Anormales	
Cual:	

Topografía	plejía	Paresia
Mono		
Hemi		
Para		
Di		
Cuadri		

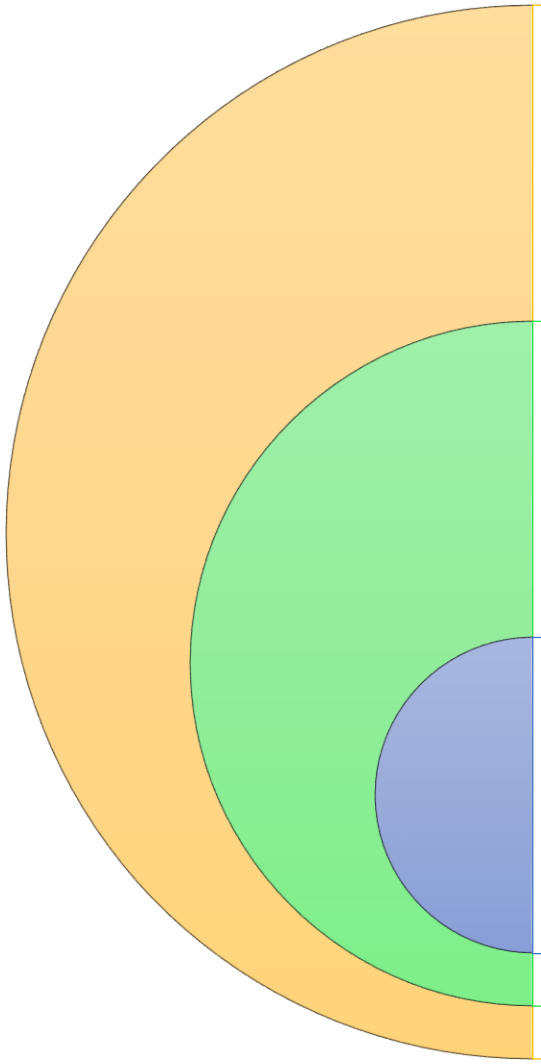
Hipotonía		
Normal		
Hipertonía		

Cuadros como hemiplejías, parálisis facial, lesiones medulares, lesiones de nervios periféricos, parkinson, etc.

¿CUÁL ES LA INTERPRETACIÓN FINAL DE LA FICHA DE EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA?

"La interpretación final de todo el proceso evaluativo se resume en el diagnóstico fisioterapéutico establecido por el Lic. T.M."

CONCLUSIONES



1. La evaluación es entendida como un proceso dinámico de análisis de información con el cual el fisioterapeuta realiza juicios clínicos basados en los datos obtenidos durante la examinación.

2. La ficha de evaluación valora las capacidades, alteraciones, deficiencias, oportunidades y complicaciones del paciente, permitiendo desarrollar protocolos de tratamiento y formular recomendaciones para su mejora siempre centrándose en la funcionalidad física del usuario.

3. La interpretación final de todo el proceso evaluativo se resume en el diagnóstico fisioterapéutico establecido por el Lic. T.M.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/5f969a3581fd7art1.pdf
- https://clinicasohail.com/valoracion-fisioterapeutica/
- https://sabadell.fisio-clinics.com/la-importancia-de-una-valoracion-en-fisioterapia#:~:text=Una%20evaluaci%C3%B3n%20fisioterap%C3%A9utica%20es%20un,actuales%20y%20los%20desaf%C3%ADos%20f%C3%ADsicos.

PREGUNTAS O INTERVENCIONES

Considerando la estructura de la evaluación fisioterapéutica, realice una ficha simple y ordene adecuadamente todos los datos brindados en el siguiente caso: La Sra. María Fernanda Pérez viuda de Martínez de 62 años ingresa a la evaluación fisioterapéutica señalando la presencia de dolor moderado en la muñeca al tratar de movilizarla junto a una disminución de la sensibilidad de la palma de la mano posterior a la fractura de muñeca derecha por la que estuvo inmovilizada con un yeso por 4 semanas. Además, menciona que se encuentra en tratamiento por el reciente diagnóstico de hipertensión y gastritis. Respecto a la ortesis (cabestrillo), estuvo indicado por las 4 semanas de yeso, pero estando ya en la semana 6 aún la mantiene por precaución, lo que provoca que sus hombros se anterioricen un poco originando una leve hipercifosis e incluso limitando un poco la marcha (por la disminución del balanceo de brazos); por ello, asistió con su hija Miriam a la evaluación. Al valorar la muñeca se evidenció un aumento de volumen de la zona y cierto edema alrededor de la misma. Los puntos de dolor principales a la palpación fueron la zona tenar de la mano, la epitróclea y el retináculo de la muñeca; por lo que el rango de la flexión, extensión y desviaciones se hallaron menores al 50% de su capacidad; asimismo, esto produjo una fuerza muscular no evaluable para la zona lesionada. Ante todo lo anterior, el Lic. Jhonatan De la Cruz definió el diagnóstico de disfunción de muñeca derecha asociada a dolor, disminución de rango y aminoramiento de fuerza muscular moderados posterior a una fractura de muñeca ipsilateral e inmovilización con yeso. El plan de tratamiento considera el empleo de termoterapia para la zona muscular del antebrazo, crioterapia en zona de fractura, masoterapia en musculatura de antebrazo y palma de la mano, movilizaciones pasivas para todos los movimientos de muñeca, estiramientos musculares y actividades para la habilidad manual.

Tiempo: 30 minutos.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MUCHAS GRACIAS

Presente.